

1. **ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ:** โครงการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วยตามเกณฑ์ บันได 10 ขั้น ผ่านการบูรณาการระบบนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล (Smart Breastfeeding for Sick Neonates: Digital BF 10 Steps)

2. **ผลงานประเภท:** CQI / แนวปฏิบัติทางคลินิกและนวัตกรรม (Clinical Practice Guidelines & Innovation)

3. **คำสำคัญ:** ทารกแรกเกิดป่วย, บันได 10 ขั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การวางแผนจำหน่าย, สื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล, อัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำ

4. **สรุปผลงานโดยย่อ:**

หอผู้ป่วยทารกเกิดถึงวิกฤตขั้น 10 (NIMCU10) พัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิดป่วยแบบองค์รวม โดยผสาน "แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลก่อนจำหน่าย" ร่วมกับ "นวัตกรรมสื่อเรียนรู้ดิจิทัลผ่าน QR-code เรื่องการปั๊มนมและเก็บรักษาน้ำนมแม่ การ Rooming in ฝึกให้นมแม่เพื่อเตรียมจำหน่าย" บนฐานเกณฑ์บันได 10 ขั้นสำหรับทารกป่วย เพื่อแก้ปัญหาคือความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการให้ข้อมูล ผลการดำเนินงานช่วยยกระดับความรู้ ทักษะ และความมั่นใจของผู้ดูแลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกกลุ่มเสี่ยง ต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างปลอดภัย ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มสูงขึ้น และลดอัตราการกลับเข้ารับการ รักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. **เป้าหมายและวัตถุประสงค์:**

1. เพื่อพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายและการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลทารกแรกเกิดป่วยของ หน่วยงานให้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วยและทารกป่วยตามเกณฑ์บันได 10 ขั้น โดย ตั้งเป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวน้ำนมแม่เมื่อจำหน่าย $\geq$ ร้อยละ 80
3. เพื่อเพิ่มคะแนนความรู้ ทักษะ และความมั่นใจของผู้ดูแลในการดูแลทารกและการจัดการน้ำนมแม่ให้ $\geq$ ร้อยละ 80
4. เพื่อลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษารักษาซ้ำ (Readmission rate) ภายใน 7 วัน ให้ไม่เกินร้อยละ 5

6. **ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:**

ทารกแรกเกิดที่มีภาวะเจ็บป่วยและทารกแรกเกิดป่วย เป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากอวัยวะยังทำงานไม่สมบูรณ์ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2023) พบว่า อัตราการคลอดก่อนกำหนดในระดับโลกสูงถึงร้อยละ 10 และจากสถานการณ์ล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีอุบัติการณ์ทารกคลอดก่อนกำหนด สูงขึ้นเกือบเกือบร้อยละ 10 หรือมากกว่า 30,000 รายต่อปี ทารกกลุ่มนี้เผชิญความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและ การกลับเข้ารับการรักษารักษาซ้ำสำหรับประเทศไทยมีอุบัติการณ์เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 8.6 ต่อปี (กรมอนามัย, 2566) สิ่ง

สำคัญที่สุดในการลดอัตราการตาย ลดการติดเชื้อในกระแสเลือด และส่งเสริมพัฒนาการของทารกกลุ่มนี้คือ "น่านมแม่" ซึ่งเปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติหยดแรกของชีวิต

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้น้อมนำและประกาศใช้ แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยเกณฑ์บันได 10 ขั้น (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยแรกเกิด, 2567) เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ทว่าในทางปฏิบัติ ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤตชั้น 10 (NIMCU10) พบข้อจำกัดเชิงระบบสำคัญ คือ ทารกต้องแยกจากการดาเพื่อรับการรักษาในวิกฤตและกึ่งวิกฤต ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทว่าด้วยข้อจำกัดที่ทารกต้องแยกจากการดาเพื่อรับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต/กึ่งวิกฤต ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหน่วยงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงร้อยละ 84.73 และ 83.39 ในปี พ.ศ. 2567, 2568 ตามลำดับ เมื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause Analysis) พบว่า ด้านบุคลากรขาดแนวทางการสื่อสารและการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พยาบาลให้ข้อมูลตักตวงแยกส่วนกันตามประสบการณ์ทำงาน ด้านผู้รับบริการมารดามีความเครียดและวิตกกังวลสูง ทำให้การรับฟังคำแนะนำด้วยวาจาไม่มีประสิทธิภาพต่ำ จดจำเนื้อหาไม่ได้ และไม่มีสื่อสำหรับนำกลับไปทบทวนที่บ้าน ส่งผลให้มารดาเริ่มบิกระตุ้นน่านมช้า ปริมาณน่านมลดลง และขาดความมั่นใจในการดูแลทารกต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าว ทีมงานจึงได้จัดทำโครงการ CQI นี้ขึ้น โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Media & Online Monitoring) เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของเกณฑ์บันได 10 ขั้น เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เข้าถึงง่าย ทลายข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ยกระดับมาตรฐานการพยาบาล และเพิ่มอัตราการได้รับน่านมแม่ในทารกป่วยอย่างยั่งยืน

7. กิจกรรมการพัฒนา:

ระยะที่ 1: วางแผนและออกแบบระบบดิจิทัล (Plan - P)

จัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และแกนนำนมแม่) ทบทวนเกณฑ์บันได 10 ขั้นสำหรับทารกป่วย และร่วมกันออกแบบชุดสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านการสแกน QR-code และระบบตรวจสอบออนไลน์โดยแบ่งเนื้อหาตามขั้นตอนนโยบายและการสื่อสารโดยการออกแบบ Infographic สรุปนโยบายบันได 10 ขั้นในรูปแบบดิจิทัล แสดงบนหน้าจอ Dashboard ของหน่วยงานและระบบ Intranet เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน มุ่งเน้นกระบวนการดูแลตามเกณฑ์อนามัยสากลและนโยบายสถาบันฯ ใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

บันไดขั้นที่ 2 การบิเก็บน่านมและคงสภาพน่านมแม่ (Initiation and maintenance of milk supply): ออกแบบสื่อสอนเทคนิคการบิกระตุ้นน่านมด้วยมือและเครื่องอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยให้มารดาสามารถเริ่มบิกระตุ้นน่านมได้เร็วที่สุดภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด แม้ต้องแยกจากบุตร

บันไดขั้นที่ 3 การบริหารจัดการน่านมแม่ (Human milk management): จัดทำสื่อแนวทางการเก็บรักษา อุณหภูมิ และการขนส่งน่านมแม่จากบ้านมายังหอผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและถูกหลักสุขอนามัย

บันไดขั้นที่ 9 การเตรียมความพร้อมเพื่อกลับบ้าน (Transition to home): ออกแบบแนวทางการเตรียมความพร้อมและระบบการให้ผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูทารกแบบใกล้ชิด (Rooming-in) เพื่อฝึกทักษะและสร้างความมั่นใจก่อนจำหน่ายกลับบ้าน

พร้อมทั้งจัดทำแบบบันทึกการติดตามปริมาณน้ำนมแม่ และแบบประเมินความรู้/ทักษะการดูแลทารกของผู้ดูแล

ระยะที่ 2: ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพสื่อ (Do - D: Part 1)

นำร่างแนวปฏิบัติการพยาบาลและสื่อดิจิทัล QR-code ทั้ง 3 ส่วน (การบีบกระตุ้น, การจัดการน้ำนม, และการเตรียมตัว Rooming-in) ส่งตรวจรับรองความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการนมแม่ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด จากนั้นนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงข้อจำกัดหน้างาน โดยพัฒนาสื่อให้เป็นภาพเคลื่อนไหว/แอนิเมชันเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมทั้งจัดทำระบบแปลภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า) เพื่อทลายกำแพงการสื่อสารและรองรับมารดา/ผู้ดูแลชาวต่างชาติได้อย่างครอบคลุม

ระยะที่ 3: ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติหน้างานแบบองค์รวม (Do - D: Part 2)

- ชี้แจงแนวทางนโยบายบันได 10 ขั้น และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทุกระดับในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤตชั้น 10 (NIMCU10) เพื่อให้เกิดความตระหนักและปฏิบัติงานบนมาตรฐานคลินิกเดียวกัน

- ติดตั้งจุด Scan QR-code ในพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายและเป็นส่วนตัวสำหรับมารดา เช่น มุมนมแม่ และข้างเตียงผู้ป่วย

- ขับเคลื่อนกระบวนการดูแลและเตรียมความพร้อมผู้ดูแลอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวปฏิบัติ ตั้งแต่วันแรกที่ทารกเข้ารับการรักษา (เน้นย้ำขั้นที่ 2 และ 3 ในระยะแรก) จนถึงกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและ Rooming-in (ขั้นที่ 9) ก่อนวันจำหน่าย โดยลงมือปฏิบัติและเก็บรวบรวมข้อมูลจริงในหน่วยงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ระยะที่ 4: ประเมินผลลัพธ์เชิงระบบ (Check - C & Act - A)

- การประเมินฝั่งผู้ดูแล (กระบวนการจำหน่ายสู่บ้าน): ประเมินระดับความรู้ ทักษะเชิงปฏิบัติ และความมั่นใจของผู้ดูแลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกแรกเกิดป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกการติดตามปริมาณน้ำนมแม่

- การประเมินฝั่งเจ้าหน้าที่ (การรณรงค์บันได 10 ขั้น): ติดตามและประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลผ่านการทบทวนอุบัติการณ์ เพื่อเฝ้าระวังและลดความคลาดเคลื่อนในการให้ข้อมูลเชิงคลินิก (ขจัดปัญหาการสอนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน)

- การประเมินผลลัพธ์เชิงคลินิก (Clinical Outcomes): รวบรวม วิเคราะห์ และ บันทึกสถิติอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่าย รวมถึงติดตามสถิติการกลับมารักษาซ้ำ (Readmission rate) ภายใน 7 วัน และ 28 วัน หลังจำหน่าย เพื่อนำข้อมูลมาสะท้อนคิด (Reflection) และปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ:

- 8.1 อัตราการกลับมารักษาซ้ำ (Readmission) ภายใน 7 วันหลังจำหน่าย ($\leq$ ร้อยละ 5)
- 8.2 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วยเมื่อจำหน่ายกลับบ้าน ($\geq$ ร้อยละ 80)
- 8.3 ร้อยละของผู้ดูแลที่มีคะแนนความรู้ ทักษะ และความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ ($\geq$ ร้อยละ 80)
- 8.4 อัตรามารดาที่มีการบันทึกติดตามการป้อนนมแม่ภายใน 24-48 ชั่วโมงแรก

($\geq$ ร้อยละ 80)

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์:

ภายหลังการนำแนวปฏิบัติแบบองค์รวมร่วมกับสื่อดิจิทัล ตามเกณฑ์บันได 10 ขึ้นมาใช้จริงเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569 พบว่า มารดาและผู้ดูแลทารกแรกเกิดป่วยมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 67.21 เป็นร้อยละ 100, มีการบันทึกกระตุ้นให้นมแม่ภายใน 24-72 ชั่วโมงแรก เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 78.63 เป็นร้อยละ 95.26 ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม 83.39 เป็นร้อยละ 90.06 ในด้านผลลัพธ์เชิงคลินิกพบว่า ไม่พบอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำภายใน 7 วัน และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อระบบงานมาตรฐานใหม่นี้สูงถึงร้อยละ 99

10. บทเรียนที่ได้รับ:

การดูแลทารกกลุ่มเสี่ยงสูงให้ปลอดภัยและยั่งยืนจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ "ครอบครัวมีส่วนร่วม (Family-Centered Care)" การนำเกณฑ์ระดับสากลอย่างบันได 10 ขึ้นมาแปลงเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย (QR-code) ช่วยทลายข้อจำกัดเรื่องข้อผิดพลาดในการสื่อสารของบุคลากร และแก้ปัญหาเรื่องเวลา/สถานที่ในการเรียนรู้ของผู้ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มอัตราการได้นมแม่และลดการ Readmission ของทารกแรกเกิดป่วยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังช่วยลดภาระงานของพยาบาลหน้างานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขในภาพรวม

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน: นางสาวสุวรรณา ศรีอินคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, หอผู้ป่วยทารกเกิดถึงวิกฤตชั้น 10 (NIMCU10)สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทร. 086-4167870 อีเมล nongnurse49@hotmail.com